高雄市鹽埕區忠孝國民小學
Kaohsiung Municipal JHONG-SIAO Elementary School

高雄市115年度教保研習

基本救命術訓練暨緊急救護情境演習

課程講義
請掃描QR code

講師:林己群

115年11月07日

真善美 Virtue
創思辦 Discernment
行永續 Sustainability

課程內容

01 基本救命術概述

02 創傷與止血

03 包紮與骨折固定

04 傷患運送

05 校園緊急事件應變流程


生存
的節奏

急救完美結合
生存之鍊



01 辨識與緊急啟動

02 高品質CPR

03 去顫

04 高級救命術

05 心跳停止後照護

06 復原與存活



民眾版CPR



叫

叫病患

看意識



叫

叫119

開擴音



壓(C)

高品質

CPR



電(D)

開 貼

插 電

線上指導急救/DA-CPR



叫

大聲呼叫患者

雙手用力拍肩



叫

打119

目視有無呼吸

或者瀕死呼吸



壓(C)

實施高品質CPR

並注意患者反應



電(D)

儘快使用AED



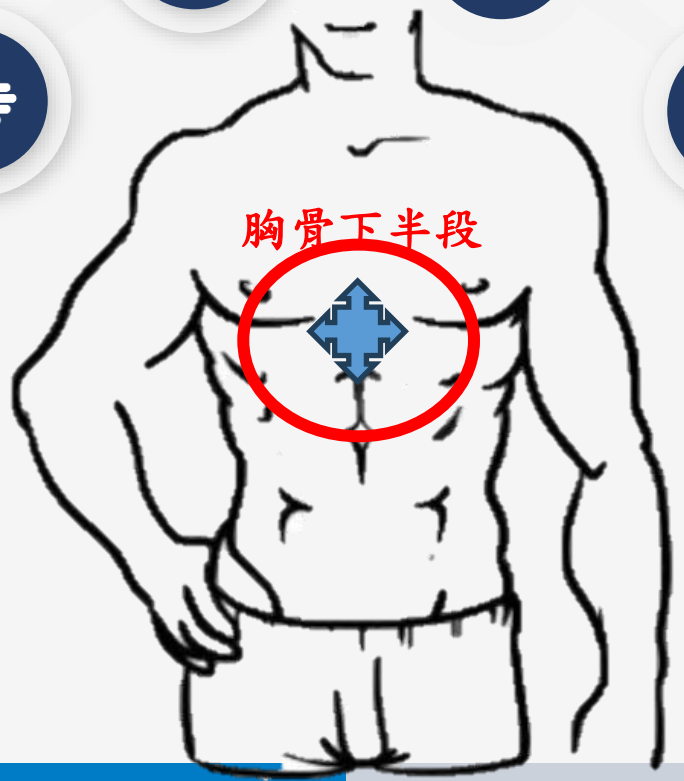
高品質CPR How to do CPR

深度 至少5公分 不超過6公分

速度 100-120下/分鐘

掌根垂直下壓 方式

技巧 胸部會完全回彈



胸口中央 (胸骨下半段) 位置

注意 中斷時間不超過10秒鐘

用力壓

快快壓

高品質CPR

胸回彈

莫中斷

自動體外去顫器



01

突發心跳停止

心臟疾病所造成的死亡，許多是以突發性心跳停止的形式發生，而電擊正是可以使心臟恢復正常心跳的方式。



02

儘早電擊

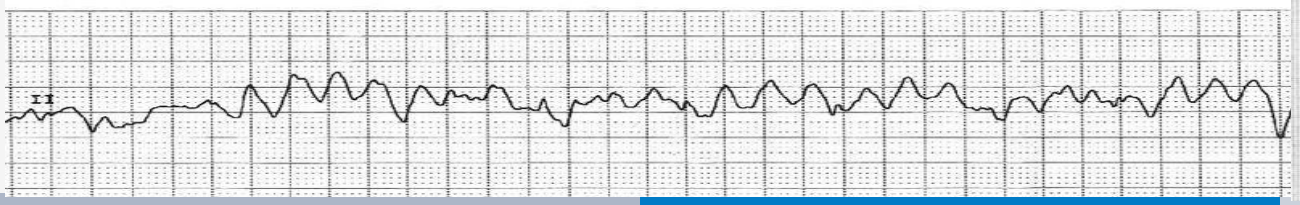
因突發性心律不整而導致心跳停止的個案，如能在一分鐘內給予電擊，急救成功率可高達90%。

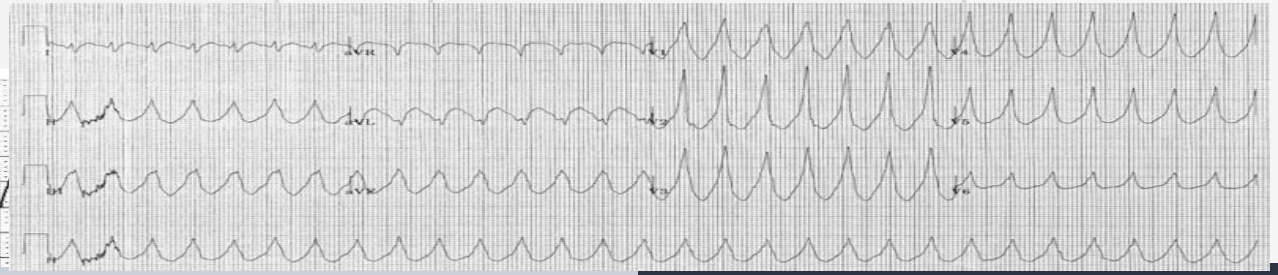


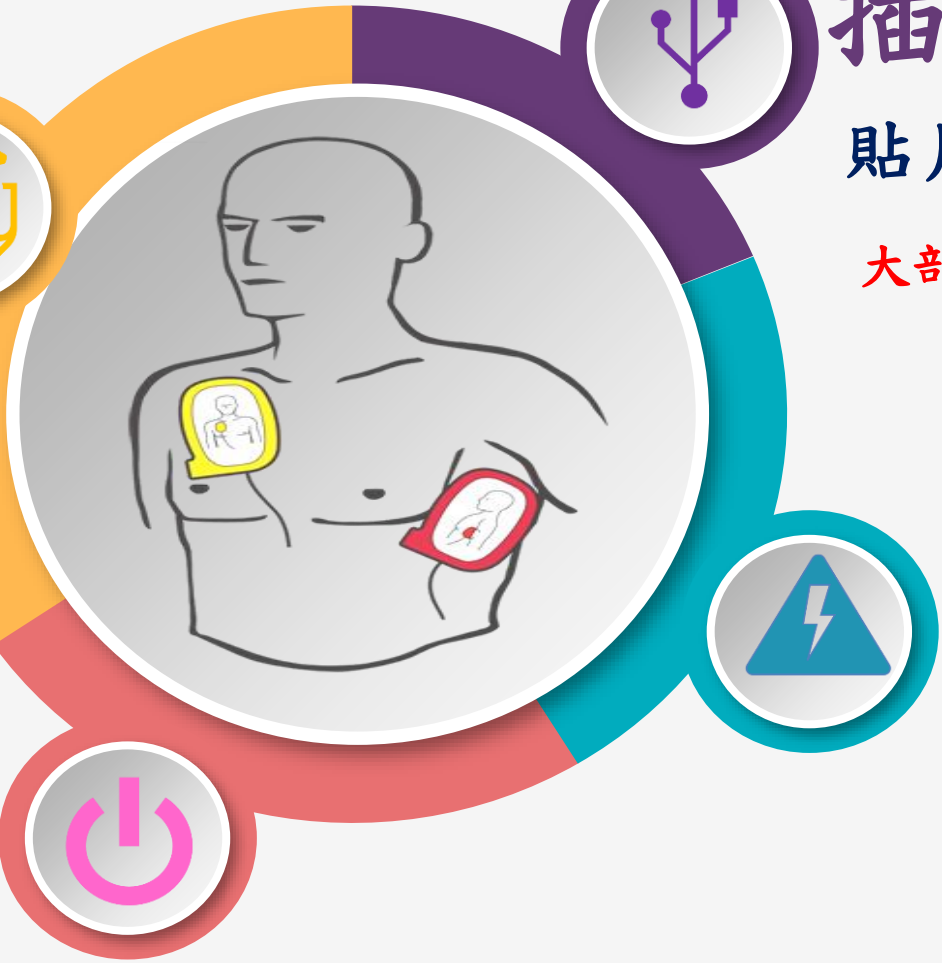
03

電擊成功率

每延遲一分鐘，成功率將遞減7-10%。







開

打開電源

聽從AED指令操作

貼

貼上電極貼片
貼上後不拆除

右鎖骨下及左腋中線

插

貼片插頭插入插孔

大部分機行都已經插好

電

分析與電擊

AED會自動分析並
建議電擊去顫

你離開～

我離開～

大家都離開～



CPR開始與結束

START and STOP



無反應+無呼吸/瀕死呼吸

叫不醒/沒有呼吸



患者有反應

CPR過程中有反應



每二分鐘換人按壓CPR

若有足夠人力

每二分鐘可換人



AED分析電擊時

AED分析與去顫電擊時

暫停按壓



專業人員接手時

119救護人員抵達接手時

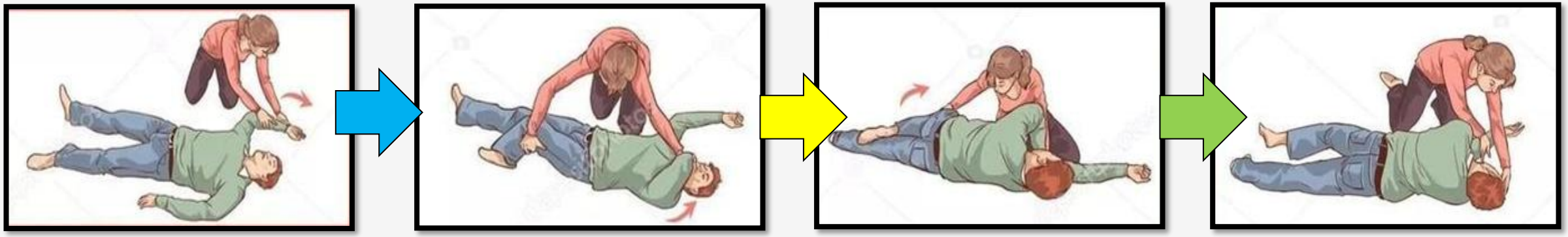


用盡洪荒之力時

偏遠山區難以運送或

長時間按壓已經無力

不需要CPR怎麼辦?



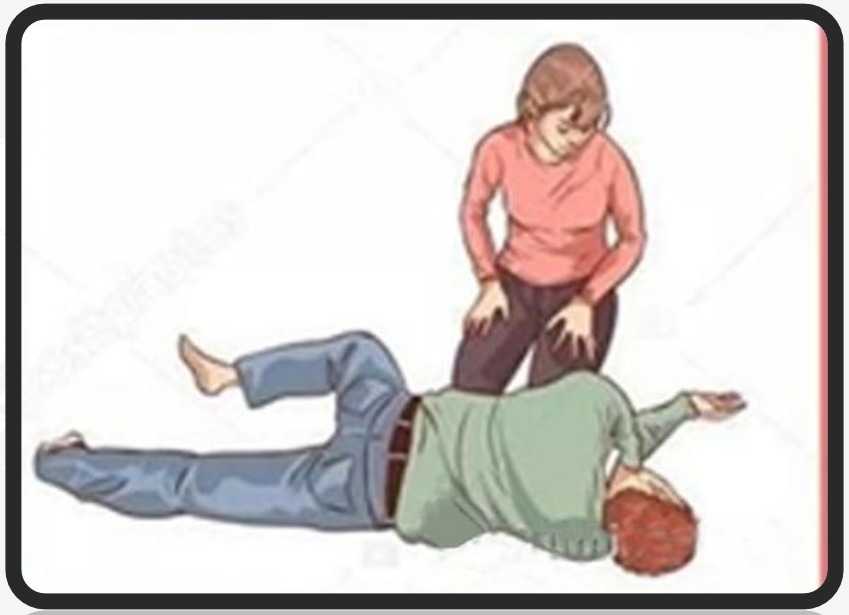
復甦姿勢

病患必須：

1、**不是創傷**導致。

2、**有呼吸**且穩定。

3、不斷**流口水**或有**鼾聲**。




Q & A



噎到了！

異物哽塞篇

foreign body airway obstruction

How to do?????

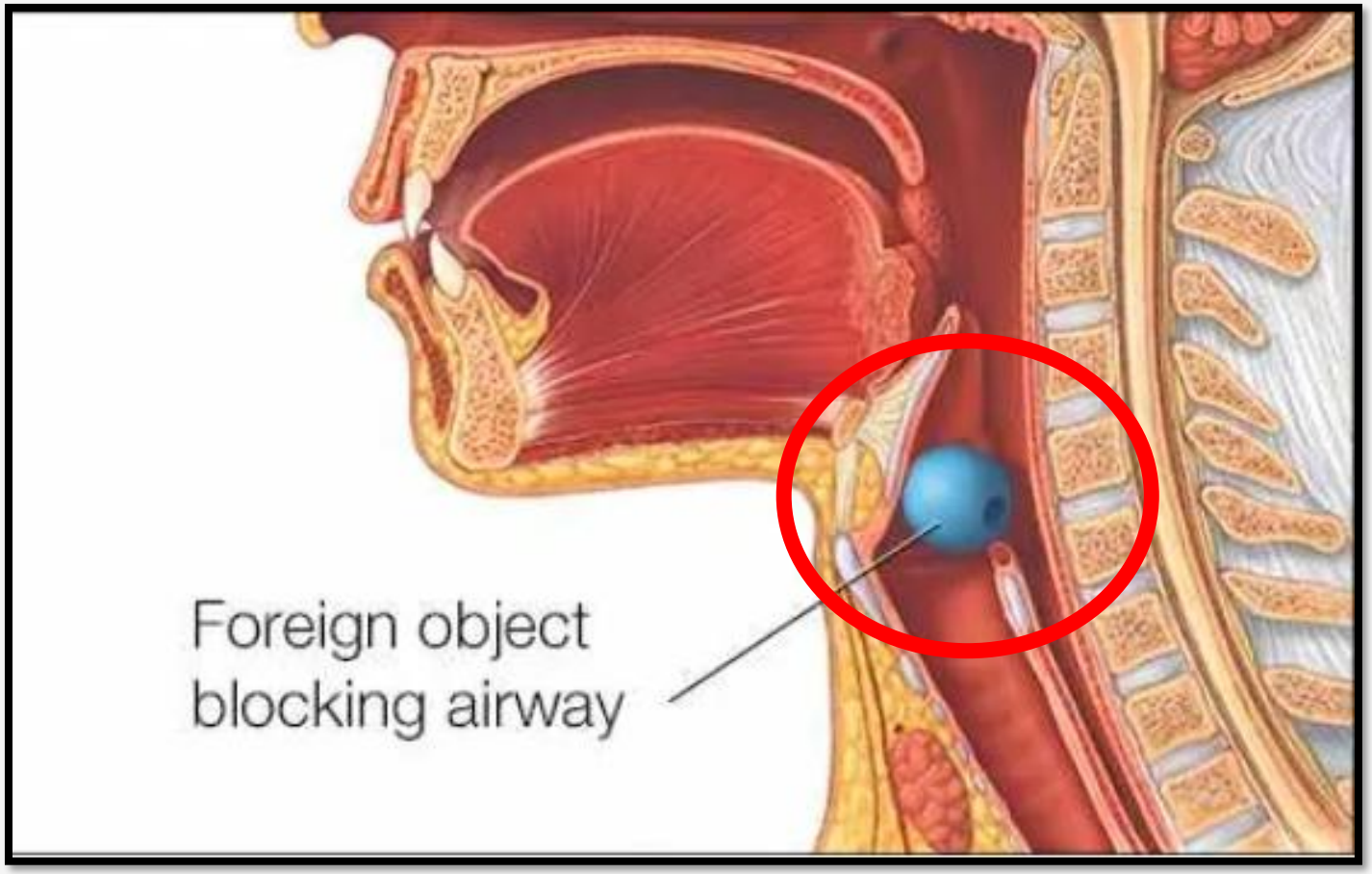
求救

自救

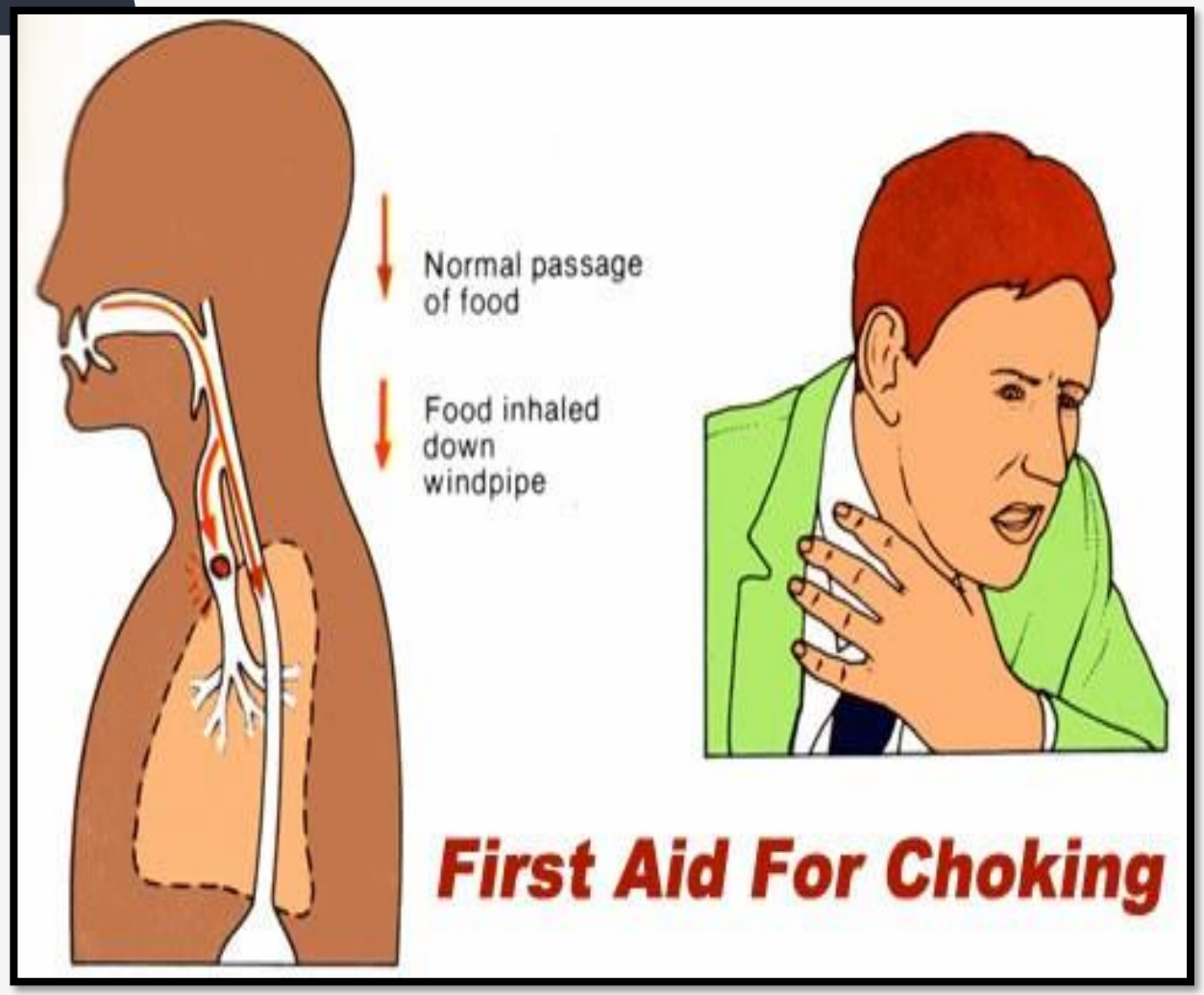
他救

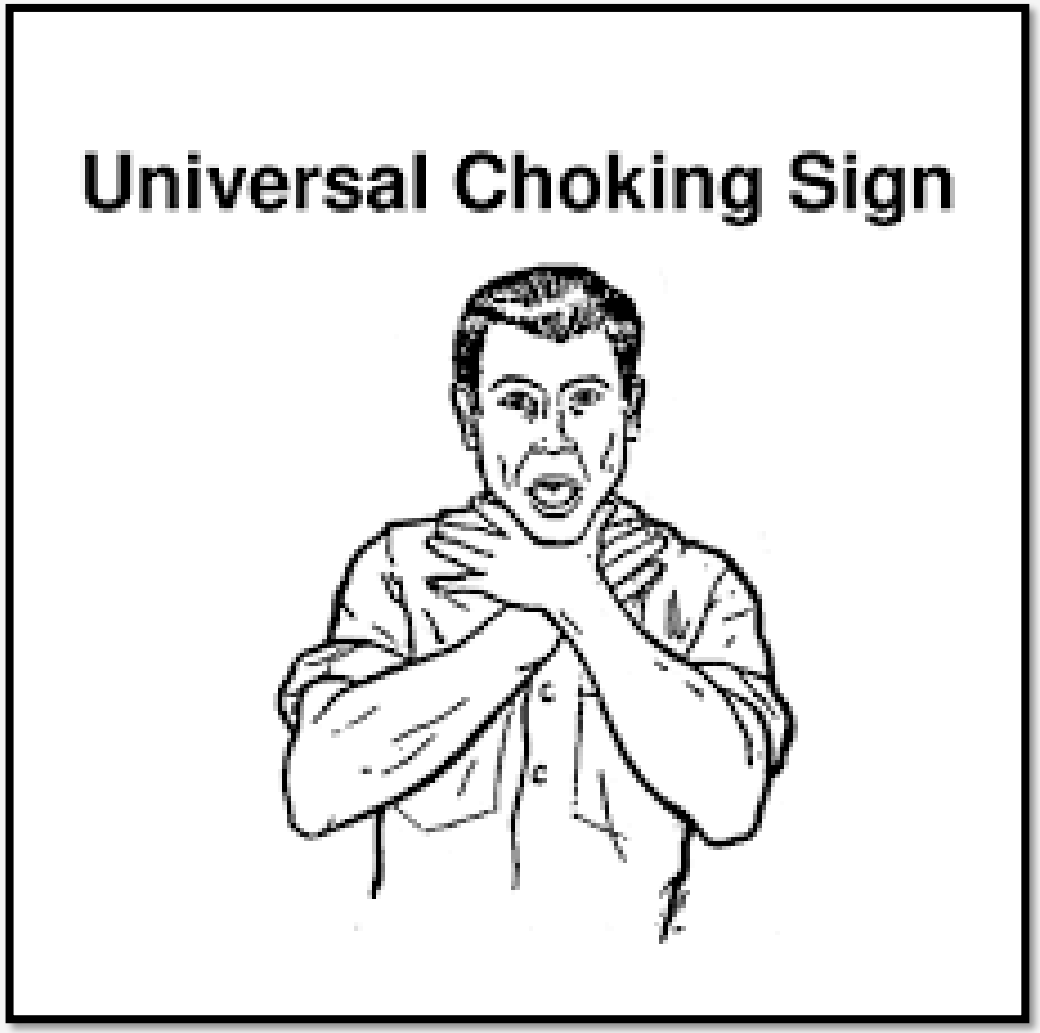
網路擷取圖片

异物梗塞原因



國際通用求救手勢


Normal passage of food
Food inhaled down windpipe
First Aid For Choking


Universal Choking Sign

>1歲　異物梗塞處置



急救五步驟

輕度異物哽塞-詢問+鼓勵咳嗽

清醒：詢問患者是否噎到?並鼓勵大力咳出來

重度異物哽塞-哈姆立克法

清醒：立即實施拍背壓腹法，重複上述步驟直到異物排出或者病患失去意識。

昏迷異物哽塞-胸外推壓

昏迷：檢查口中異物，清除異物，進行胸外按壓。

啟動緊急醫療系統-求救+送醫

撥打119求救，聽從派遣員指導急救。

01 辨識詢問求救

02 鼓勵咳嗽

03 拍背壓腹

04 哈姆立克

05 送醫急救

翻轉生命的手勢/哈姆立克



拍背



網路擷取圖片

剪刀

在肚臍上方二指幅高度定位



石頭

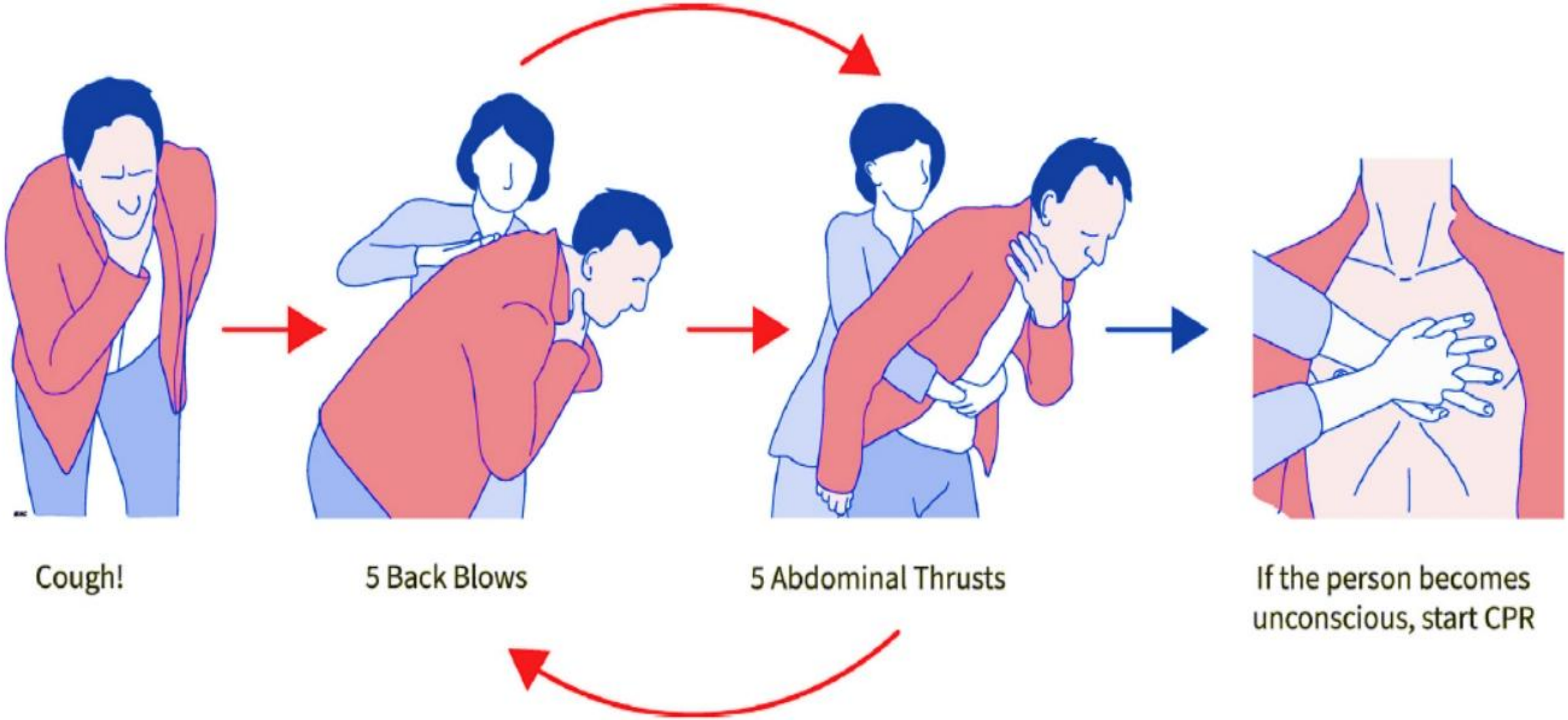
握拳將拳眼朝內緊貼腹部



布

另一隻手包覆拳頭並環抱身體





輕微阻塞
鼓勵咳嗽

嚴重阻塞
拍背五下

重複循環
壓肚五下

昏迷倒下
胸部推壓



孕婦、肥胖者

按壓位置可以改成胸骨下半段處

自救



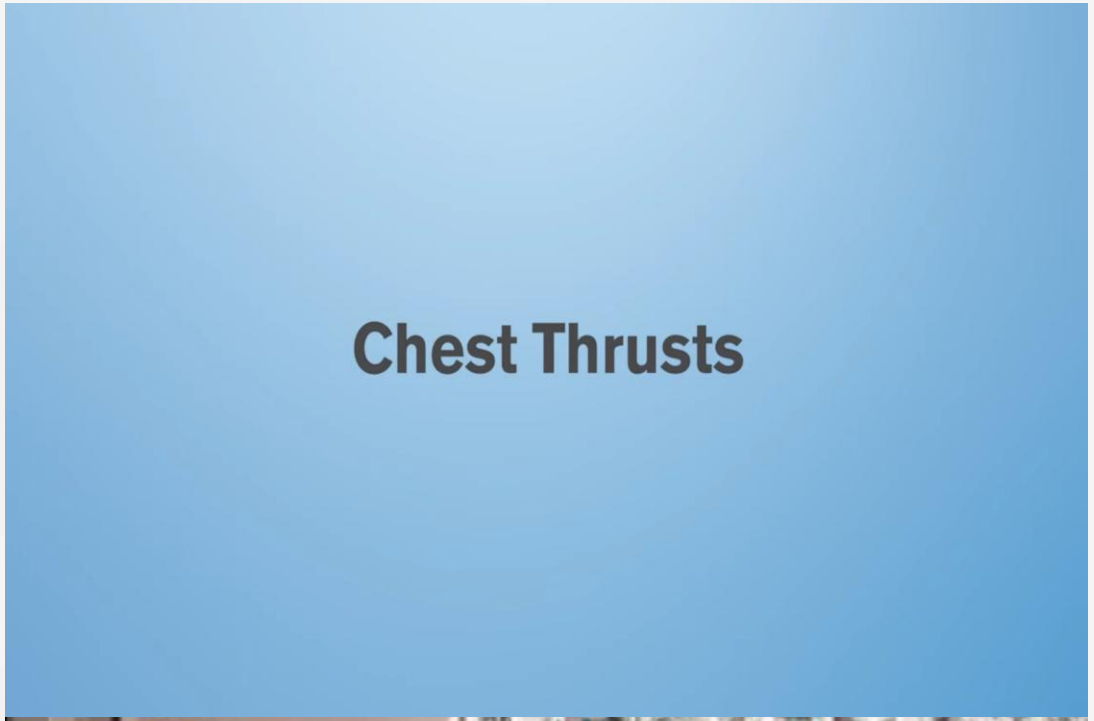
無人可以急救時可以嘗試找椅背或利用平坦、堅固的椅背邊緣，自行於肚臍稍上方的腹部做快速用力的擠壓，將異物排出。

兒童



施救者可以降低高度或者將被救者增加高度

前胸貼後背





<1歲　拍背壓胸法









嬰兒哈姆立克法

拍背

肩夾中央拍五下



翻身

三明治翻身法



壓胸

掌根壓胸五下



網路擷取圖片

Q & A





網路擷取圖片

校園事故!

緊急止血篇

foreign body airway obstruction

How to do?????

求救

自救

他救

緊急止血急救流程

肢體出血

↓

自身保護

↓

直接加壓止血-10 分鐘

↓

持續出血再次加壓-直接覆蓋

↓

無法止血-使用止血帶

致命性的出血-噴溼斷

搏動性出血

噴





地上血液聚積或
衣物被血液浸濕

溼





手臂或小腿
部或及其以
上截肢

斷



直接加壓止血法

最直接有效的戰術。



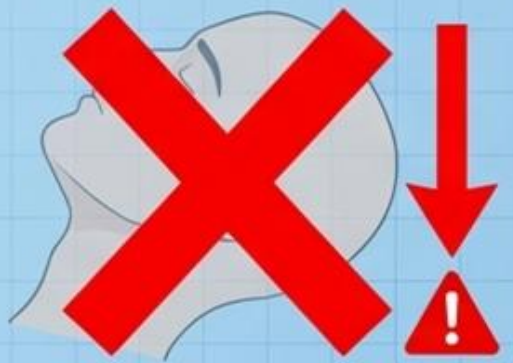
鼻子出血處置

正確：頭部微低

正確：捏住鼻翼



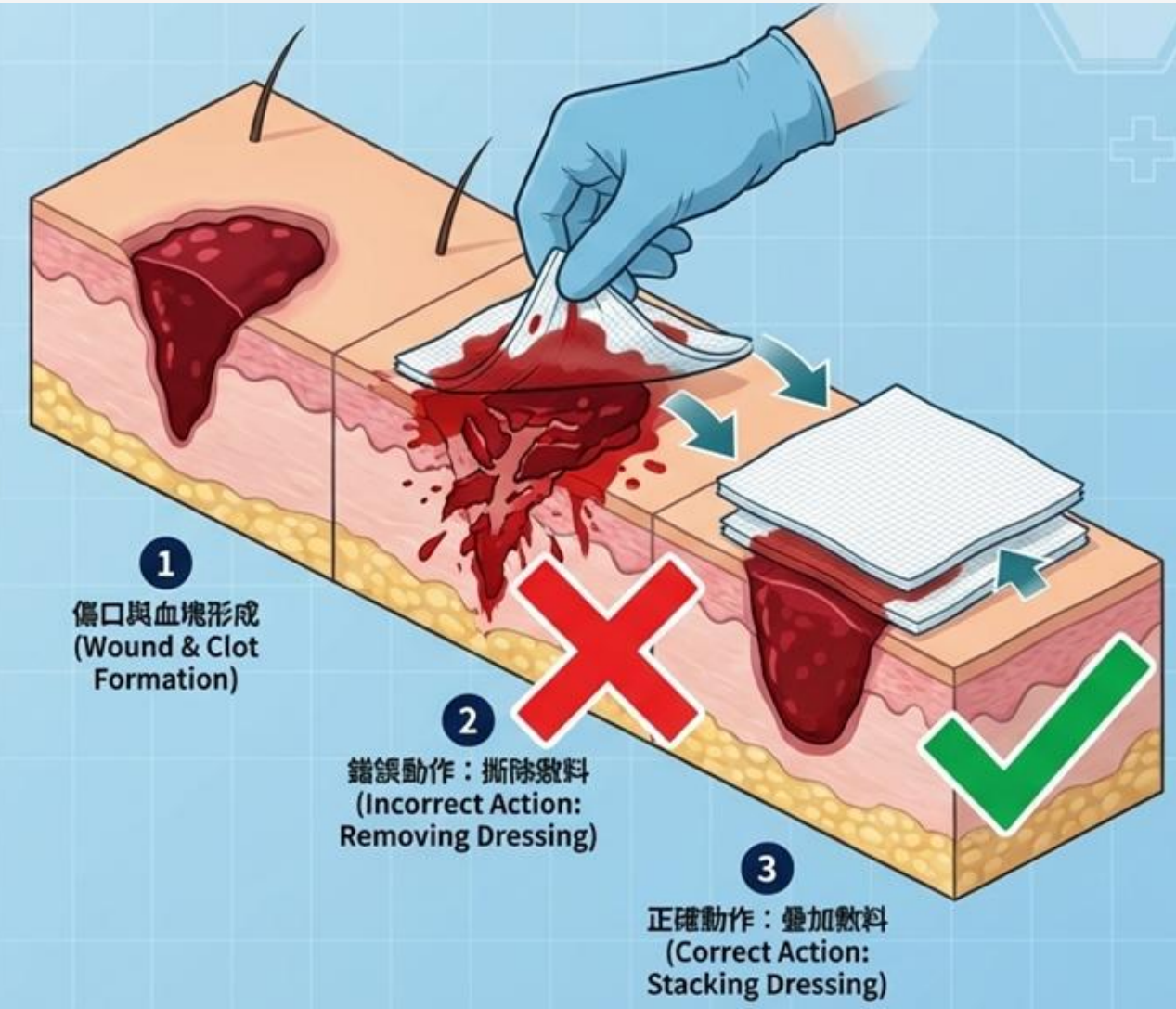
破除迷思：切勿後仰



溫和清潔：優先以生理食鹽水沖洗。若無，可用濕紗布配合生理食鹽水清潔。

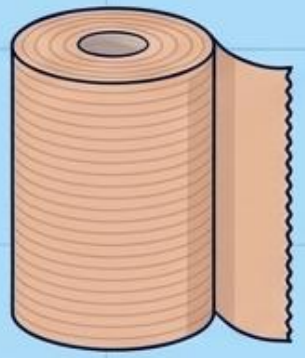
正確覆蓋：敷料應直接且完全覆蓋在傷口上，不可由旁邊滑動蓋住傷口。

不拆舊料：若血滲透敷料時，不可拆掉原來的敷料。



行動急救百寶箱：包紮器材總覽

彈性繃帶
(提供壓力與固定)



1

滅菌紗布
(吸收滲液與保護)



2

透氣膠布
(固定敷料)



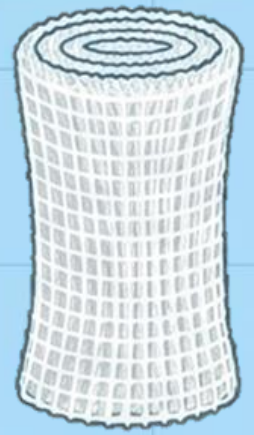
3

三角巾
(懸吊與大面積包紮)



4

網套
(適用於頭部或關節處快速固定)



5

彈性繃帶包紮法

環狀包紮法

用於起頭（定帶）、收尾，或包紮範圍較小的傷口。



螺旋包紮法

用於肢體粗細均勻處，大面積覆蓋傷口。



懸臂吊帶包紮法

適用範圍：

肩、肘、腕關節、前臂及上臂骨折。

關鍵心法：

先將患處固定，再做懸臂吊帶。



腳踝扭傷









骨折急性期處理PRICE原則

止血是保命，固定是防二度傷害

P
保護
Protect

固定患處，防止二次傷害。使用夾板或護具。



R
休息
Rest

停止活動，患處不承重。



I
冰敷
Ice

受傷前48小時，每次15-20分鐘，減輕疼痛腫脹。



C
加壓
Compress

使用彈性繃帶包紮，控制內部出血。



E
抬高
Elevate

患肢抬高於心臟水平，促進淋巴回流。



黃金處理時期：傷後48小時內。警訊：遠端發紫、麻痺立即鬆解！

骨折固定的 8 大戰術原則

評估階段

- 1. 優先處置致命性出血
- 2. 評估腫、痛、畸形與對稱
- 3. 開放性骨折先包紮

執行階段

- 4. 原姿勢固定
- 5. 固定範圍需超過骨折近端與遠端關節
- 6. 選擇合適固定器材

檢測階段

- 7. 固定前後檢查脈搏、感覺及運動功能
- 8. 盡速送醫

固定器材大百科：專業器材 vs. 生活替代物

醫療常規器材



木質夾板：堅固可靠的基礎支撐。



捲式護木（SAM Splint）：輕便可塑形，適應各種曲線。



抽吸式護木：貼合抽真空，提供全面固定。

還有其他替代物品嗎？(緊急應變)



隨身物品：雨傘、厚雜誌



打掃工具：掃把、雞毛撢子



人體夾板：另一隻腳（健肢）緊綁固定！

Q & A



傷病患搬運

搬運五大原則

搬運
原則



強壯肌肉

親密相隨



量力而為

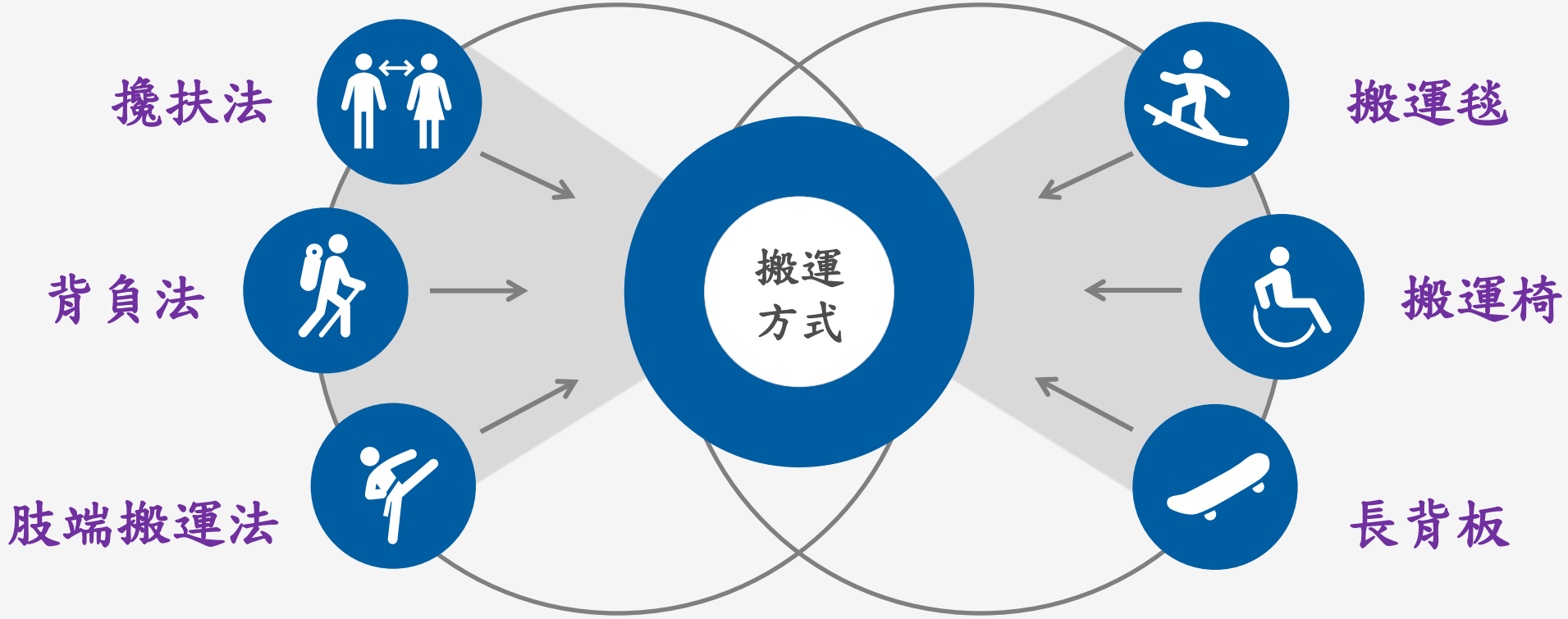


步步為營



頂天立地

搬運方式



徒手搬運法



攙扶法



背負法



肩負法

器材搬運法(就地取材)







Q & A



校園緊急事件應變



永遠意想不到的突發事件

應變

求救

急救

網路擷取圖片

校園求救五元素

其他人



校護



AED



撥打119電話



引導救護車



急救安全
事件評估

應變



CPR+AED
止血 包紮

急救

校園求救
119 求救

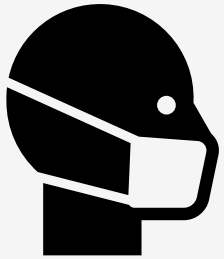
求救

校園意外傷害事故-緊急應變原則



安全評估
排除危害

武力威脅



自我防護
手套口罩

感染控制



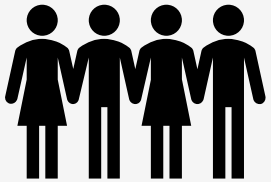
求救支援
對內對外

校護消防



壓胸急救
CPR

所有人員



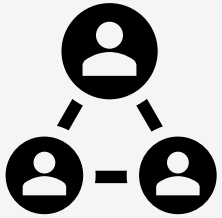
檢傷分類
救最嚴重

多重傷患



急救送醫
自送他送

評估送醫



通報紀錄
家屬長官

解釋通報

Q & A




立即求救
撥打119
119

Q & A



高雄市鹽埕區忠孝國民小學
Kaohsiung Municipal JHONG-SIAO Elementary School

高雄市115年度教保研習

基本救命術訓練暨緊急救護情境演習

問卷回饋
請掃描QR code

真善美 Virtue
創思辦 Discernment
行永續 Sustainability

高雄市鹽埕區忠孝國民小學
Kaohsiung Municipal JHONG-SIAO Elementary School

高雄市115年度教保研習

基本救命術訓練暨緊急救護情境演習

謝謝蒞臨!!



真善美 Virtue　創思辦 Discernment　行永續 Sustainability

